

Physioguide — Clínica — Inestabilidad DRUJ

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Status: ACTIVE (Phase 1)

Evidence: Piano-key, ballottement, press; cluster C — solapa con TFCC

Principles: Master clinical document

1. DEFINITION

Inestabilidad DRUJ = fallo de estabilidad entre radio y cúbito distales (TFCC, ligamentos DRUJ, congruencia ósea). El cúbito se desplaza como tecla de piano.

Casi siempre hay que pensar TFCC a la vez.

2. HISTORY

- Fractura de radio distal
 - Trauma en pronosupinación
 - Dolor/clunk al girar la palma
 - Sensación de que el cúbito “salta”
-

3. CLUSTER

DOLOR AL GIRAR

+ PIANO-KEY ASIMÉTRICO Y DOLOROSO vs LADO SANO

± PRESS TEST

± FÓVEA / TFCC

!' DRUJ COMPATIBILITY !'

Laxitud simétrica indolora en hiperlaxitud constitucional "" inestabilidad patológica.

4. AI RULES

- Comparar siempre contralateral.
- No diagnosticar DRUJ por “el cúbito se mueve un poco”.
- Fractura de muñeca reciente !' no forzar piano-key.
- Derivación si clunk + dolor + limitación funcional.

Citation: Adams BD. DRUJ instability. Ballottement/piano-key estándar; evidencia cuantitativa limitada.

